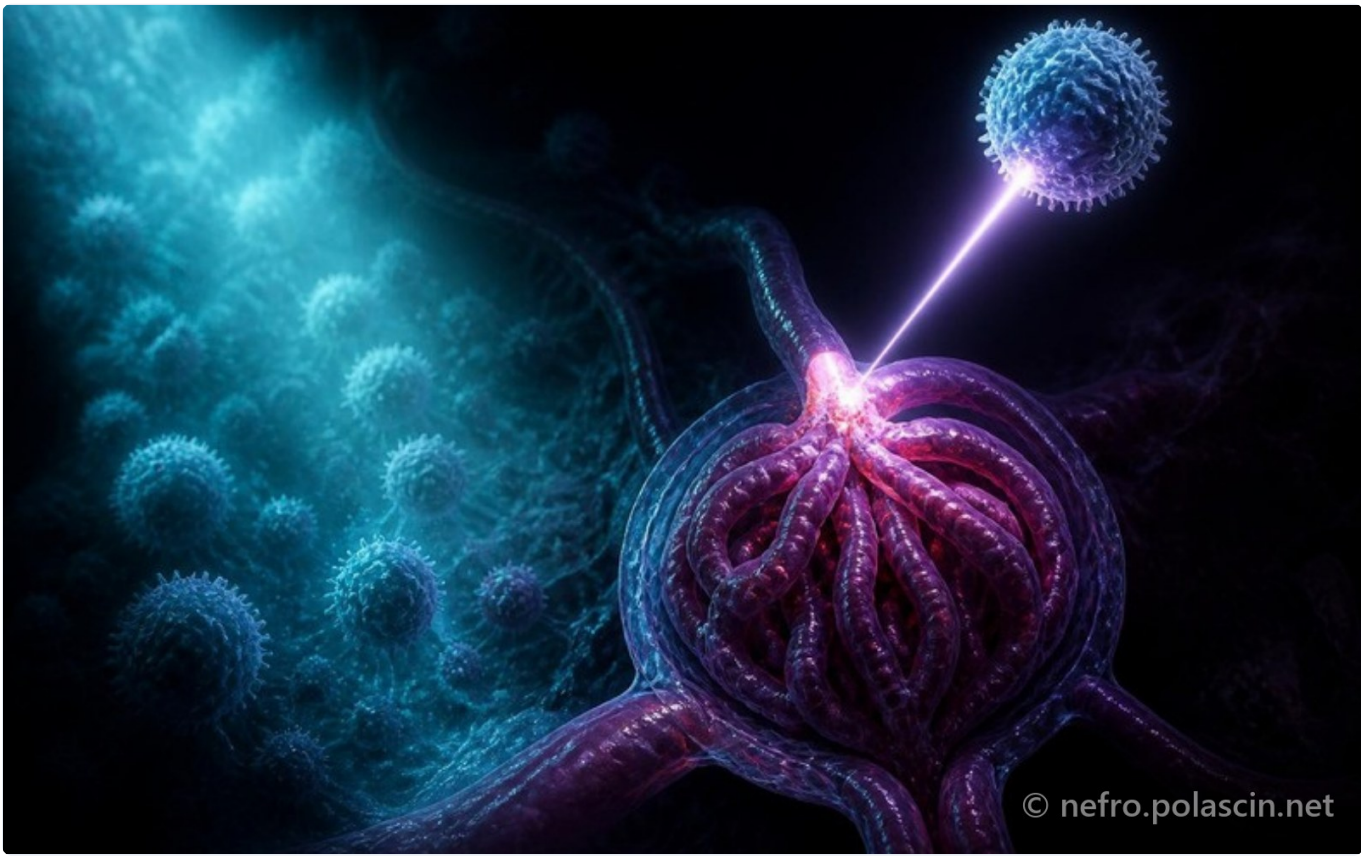
IgA nefropatia v ére nových terapeutických možností: od podpornej liečby k cielenej terapii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 11.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Podporná liečba zostáva základom — nad ňou však pribúda cielený zásah do príčiny.

IgA nefropatia patrí medzi najčastejšie glomerulové ochorenia na svete. Napriek tomu, že je známa desaťročia, jej liečba prechádza jednou z najvýznamnejších zmien. Nové poznatky o patogenéze a nové lieky posúvajú klinickú prax od všeobecnej nefroprotekcie k cielenej terapii zasahujúcej konkrétne mechanizmy ochorenia.

Klinický priebeh je veľmi variabilný: od dlhodobo miernych foriem až po progresiu do chronickej choroby obličiek a terminálneho zlyhania. Typickým prejavom u mladších pacientov býva synfaryngitická makroskopická hematúria, u starších skôr mikroskopická hematúria s rôznym stupňom proteinúrie.

Štvorzásahový model: prečo ochorenie progreduje

Súčasné chápanie IgA nefropatie vychádza zo štvorzásahového modelu: tvorba galaktózovo deficitného IgA1, vznik autoprotilátok, tvorba imunitných komplexov a ich ukladanie v mezangiu glomerulov. Následne sa aktivuje zápal, komplement a procesy vedúce k postupnému poškodeniu obličkového tkaniva.

Práve tento patofyziologický rámec umožnil vývoj liekov, ktoré cielia slizničnú produkciu patologického IgA, B-bunkové signály, komplementové dráhy aj mechanizmy spojené s proteinúriou a fibrózou.

Proteinúria ako hlavný terapeutický cieľ

Nové odporúčania KDIGO kladú dôraz na prísnejšie ciele proteinúrie. U pacientov s rizikom progresie má byť cieľom znížiť proteinúriu aspoň pod **0,5 g/deň**, ideálne pod **0,3 g/deň**. Tento cieľ má praktický význam, pretože proteinúria je dôležitý marker aktivity ochorenia aj prediktor budúceho poklesu renálnej funkcie.

Základ zostáva rovnaký: kvalitná nefroprotekcia

Podporná liečba zostáva základom manažmentu IgA nefropatie a má byť optimalizovaná včas. Kľúčové sú najmä ACE inhibítory alebo sartany, dôsledná kontrola krvného tlaku, inhibítory SGLT2 u vhodných pacientov, režimové

opatrenia a systematické znižovanie proteinúrie.

Dáta zo štúdií DAPA-CKD a EMPA-KIDNEY podporujú nefroprotektívny účinok inhibítorov SGLT2 aj pri proteinurických fenotypoch vrátane IgA nefropatie.

Nové cielené možnosti liečby

Medzi dôležité novinky patria antagonisty endotelínového receptora. **Sparsentan** ako duálny antagonista angiotenzínového a endotelínového receptora viedol v štúdii PROTECT k výraznejšiemu poklesu proteinúrie než irbesartan. **Atrasentan** (štúdia ALIGN) priniesol významné zníženie proteinúrie oproti placebu, pri liečbe je však potrebné sledovať najmä retenciu tekutín.

Cielený budezonid využíva črevno-obličkovú os a uvoľňuje sa v distálnom ileu, kde pôsobí na Peyerove plaky. Štúdia NefIgArd ukázala zníženie proteinúrie a priaznivejší vývoj eGFR v porovnaní s placebom.

Iptakopan, inhibítor faktora B alternatívnej komplementovej dráhy, v štúdii APPLAUSE-IgAN významne znížil proteinúriu. Pri tejto liečbe je dôležitá prevencia infekcií opuzdrenými baktériami vrátane adekvátneho očkovania.

Významnú pozornosť pútajú aj lieky cieliace APRIL/BAFF osi. **Sibeprenlimab** (anti-APRIL protilátka) podľa dostupných údajov vedie k významnému poklesu proteinúrie. Ďalšie molekuly, ako atacicept alebo povetacicept, sú vo vývoji.

Individualizácia rozhodovania v praxi

Moderná liečba IgA nefropatie si vyžaduje individualizáciu podľa výšky proteinúrie, dynamiky eGFR, krvného tlaku, histologického nálezu, veku, komorbidít, rizika nežiaducich účinkov, plánovania tehotenstva, dostupnosti liečby a preferencií pacienta.

Diagnóza ostáva postavená na renálnej biopsii a prognostickom hodnotení (vrátane MEST-C), pričom výber liečby nemá byť mechanický, ale klinicky cielený.

Záver

IgA nefropatia vstupuje do novej terapeutickej éry. Podporná liečba zostáva nevyhnutným základom, no už nie je jedinou možnosťou. Kombinácia nefroprotekcie a cielenej imunomodulácie umožňuje presnejší zásah do biologického podkladu ochorenia a otvára priestor pre lepšie dlhodobé renálne výsledky.

Zdroj: odborné zhrnutie aktuálnych terapeutických trendov v IgA nefropatii, vrátane odporúčaní KDIGO a dát zo štúdií PROTECT, ALIGN, NeflgArd, APPLAUSE-IgAN, DAPA-CKD a EMPA-KIDNEY

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-v-ere-novych-terapeutickych-moznosti · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.